

G5-2 小兒危急個案

程 序

小兒傷病患依下列四項指標定義為「危急個案(ALS個案)」(註1)

一、生命徵象指標

- (一) 意識不清(昏迷指數<13 分)。
- (二) 呼吸窘迫的徵候(註 2)或未給氧時血氧值<94%。
- (三) 脈搏數：
 - 1、年齡<3 個月：脈搏每分鐘<110 或≥170 次。
 - 2、年齡 3 個月至 3 歲：脈搏每分鐘<90 或≥150 次。
 - 3、年齡≥3 歲：脈搏每分鐘<60 或≥130 次。
- (四) 收縮壓：收縮壓低於 $[70 + (2 \times \text{年齡})]$ mmHg。(適用於 1-10 歲)
- (五) 微血管充填時間≥2 秒。
- (六) 體溫≥40°C 或<36°C。
- (七) 血糖值<60 mg/dl(或顯示 low)或≥500 mg/dl(或顯示 high)。
- (八) 發紺。

二、傷病部位指標

- (一) 燒燙傷：2 度燒傷體表面積 18% (含) 以上或 3 度燒傷體表面積 10% (含) 以上，或顏面燒燙傷、會陰燒燙傷、吸入性燒灼傷。
- (二) 大量皮下氣腫。
- (三) 手腕或腳踝以上截肢、大而深的傷口。
- (四) 頭、頸、軀幹(開放性傷口，含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或重物輾壓傷。
- (五) 嚴重骨折：≥2 處長骨骨折(此處所稱長骨指上臂、前臂、大腿、小腿)、連枷胸、骨盆骨折、開放性或凹陷性顱骨骨折。
- (六) 腦組織或內臟外露。
- (七) 頭部或脊椎傷害併肢體癱瘓。
- (八) 長骨開放性骨折。

三、傷病機轉指標

- (一) 高處墜落：小兒童身高 2 倍以上之墜落。
- (二) 脫困時間≥20 分鐘。

(三) 高能量撞擊之證據。例如：汽車車速 ≥ 50 公里/小時、內部乘員空間凹陷 ≥ 30 公分、同車有人死亡、被彈出車外、行人或機車騎士被高速（ ≥ 50 公里/小時）汽機車撞擊、彈飛、或輾壓（遠端肢體除外）。

(四) 爆炸傷。

四、特殊狀況

(一) 缺血性胸痛發作。

(二) 突然或近期昏迷。

(三) 抽搐不止。

(四) 中毒可能危及生命。

(五) 急產。

(六) 情況異常或不穩定之嬰兒或兒童，可參考小兒三角評估。

(七) 毒蛇咬傷。

要 旨

一、適用於小於18歲或尚未出現第二性徵的兒童，若8歲以上或體型較大（目測可能超過25公斤以上）之兒童，可依成人相關程序處理。

二、因為危急個案有較高的可能性發生到院前心跳停止，故EMT於現場或車上處置此類病患的同時，須更加注意瀕死徵象的發生，以儘早開始必要的急救。

三、危急個案應每5分鐘進行一次生命徵象評估，使用正壓通氣(BVM)的病患應每2分鐘進行生命徵象評估；並於期間注意瀕死徵象的發生。

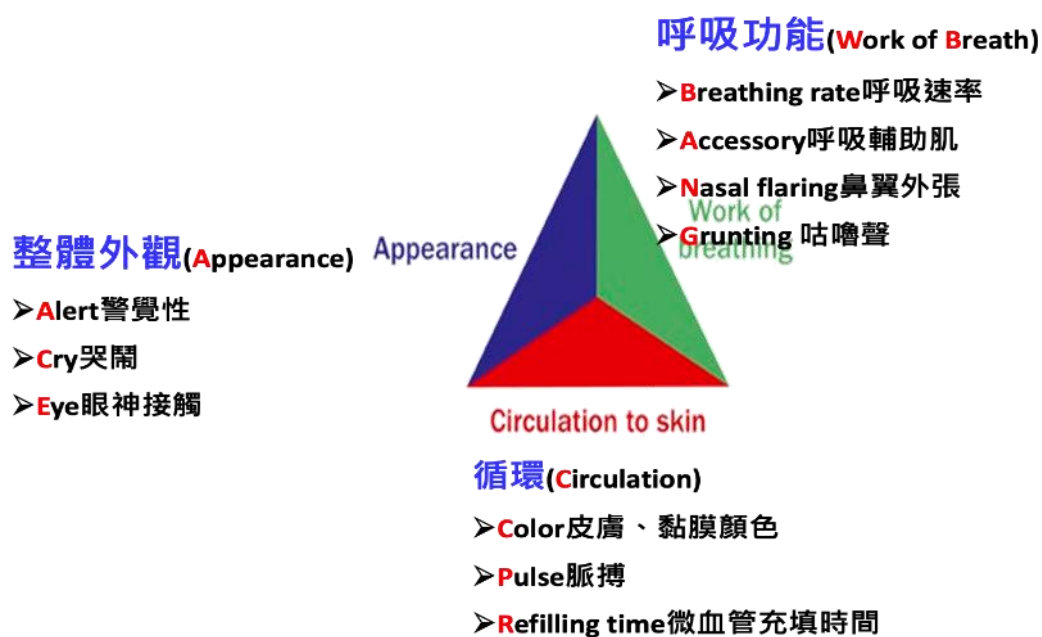
四、如重大外傷應依規定進行通報並後送合作醫院，以利病患預後。

註 解

註1>

一、若傷病患同時符合多項危急個案定義，應同時通報救災救護指揮中心及告知醫院。

二、四大項指標與相關生命徵象數值非唯一判斷依據，小兒仍須根據三角評估(Pediatric Assessment Triangle, PAT)，做綜合判斷。



A	B	C	初步臆斷
正常	異常	正常	呼吸問題 (呼吸窘迫)
異常	異常	正常	嚴重呼吸問題 (呼吸衰竭)
正常	正常	異常	循環問題 (代償性休克)
異常	正常	異常	嚴重循環問題 (低血壓性休克)
異常	異常	異常	心肺衰竭 (考慮立即進行 CPR)
異常	正常	正常	考慮中樞神經系統、中毒或代謝問題

註2>

呈現異常姿勢（嗅吸姿勢或點頭式呼吸）、呼吸作功（胸部在吸氣時發生肋骨間的軟組織凹陷、是否使用呼吸輔助肌或嬰幼兒特有的鼻翼煽動）與呼吸雜音（喘鳴、哮鳴或咕嚕聲）。